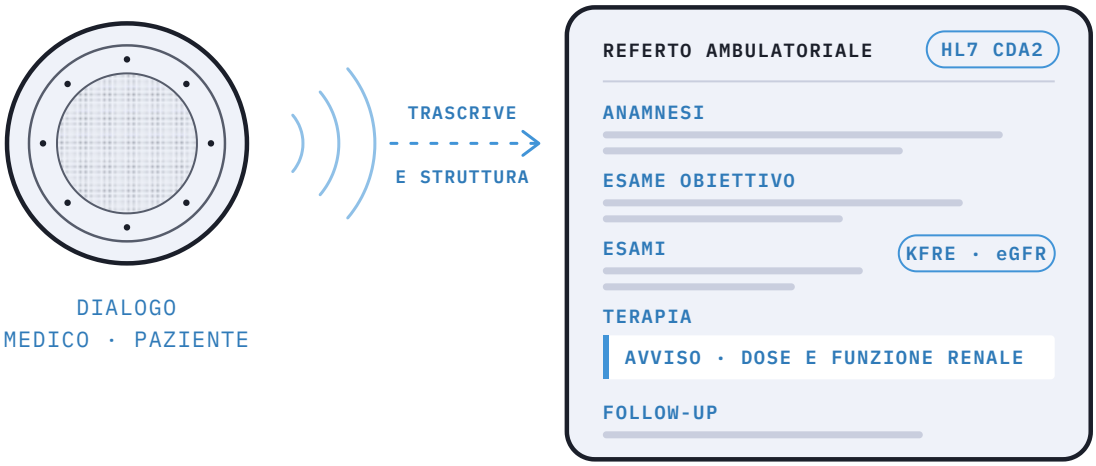
NEFROLOGIA · AMBULATORIO — REV. 02 · OTTOBRE 2026

PIÙ TEMPO AL PAZIENTE, MENO ALLA TASTIERA

Ambulatorio AI è il modulo di GepaDial che ascolta la visita nefrologica, la trascrive e prepara il referto per la firma. Mentre il medico parla con il paziente, il sistema compila le sezioni, segnala allergie e dosaggi, calcola gli score. I modelli, addestrati sulla nefrologia, risiedono nell'azienda ospedaliera. La decisione resta del medico.

TRASCRIZIONE IN TEMPO REALE | AVVISI CLINICI | MODELLI ON-PREMISE | FSE 2.0



DIALOGO MEDICO · PAZIENTE

REFERTO PRONTO PER LA FIRMA

01 **CONTESTO**
Allergie, terapie, esami e ultime visite già in vista

02 **VISITA**
Il medico parla; il sistema trascrive e compila

03 **VALIDAZIONE**
Avvisi accettati o ignorati, sezioni corrette

04 **FIRMA**
Referto CDA2 al repository e al FSE

NEFROLOGIA · HL7 CDA2 · KFRE · EGFR · ITALIANO · AUDIO: 0 S

OBIETTIVO

1/2

DEL TEMPO DI SCRITTURA DEL REFERTO*

AUDIO CONSERVATO

0 s

SEZIONI COMPILATE

5

VISTA DI LAVORO

1

* Obiettivo della sperimentazione in corso, su visite simulate da medici e infermieri. Il valore sul campo sarà misurato nel pilot.

DOVE VA IL TEMPO DI UNA VISITA

In ambulatorio il tempo clinico si consuma in quattro momenti che clinici non sono: raccogliere i dati, trascrivere, compilare il referto, chiudere la pratica. Ambulatorio AI interviene su ciascuno.

01 **Prima della visita il contesto è già pronto**

All'apertura arrivano allergie, terapie, problemi attivi, esami degli ultimi sei mesi e ultime tre visite: una vista sola.

02 **Durante la visita si parla, non si scrive**

Il dialogo è trascritto in italiano in tempo reale e compila anamnesi, esame obiettivo, esami, terapia e follow-up.

03 **Gli avvisi arrivano quando servono**

Allergie, interazioni, dosaggi inadeguati alla funzione renale, dati mancanti: segnalati durante la visita, non dopo.

04 **Alla chiusura il referto esiste già**

Il documento CDA2 è composto: il medico rilegge, corregge e firma. Invio al repository e al FSE, erogazione CUP contestuale.

LA VISITA, PASSAGGIO PER PASSAGGIO

PASSAGGIO	OGGI	CON AMBULATORIO AI
CONTESTO CLINICO	Si ricostruisce aprendo più schermate: cartella, laboratorio, foglio terapia.	È già in vista all'apertura: allergie, terapie, problemi attivi, esami recenti, ultime visite.
DURANTE LA VISITA	Il medico ascolta e intanto scrive, o rimanda la scrittura a dopo.	Il medico parla e guarda il paziente; la trascrizione compila le sezioni.
AVVISI E CALCOLI	Interazioni e dosaggi si verificano a mano; eGFR e score si calcolano a parte.	Avvisi in tempo reale su allergie, interazioni e dosaggi; eGFR e KFRE automatici.
CHIUSURA	Referto da scrivere, firmare e caricare; prestazione da chiudere a CUP dopo.	Referto CDA2 già composto: rilettura, firma, invio a repository e FSE, erogazione CUP.

DURANTE LA VISITA

- Trascrizione in italiano, in tempo reale, dal vivavoce da scrivania o dall'unità wireless da bordo letto; un test verifica prima la qualità dell'audio.
- Estrazione dei dati strutturati: anamnesi, esame obiettivo, esami, terapia, follow-up. L'anamnesi parte precompilata dall'ultima visita.
- Avvisi in tempo reale su allergie, interazioni, valori di laboratorio, dosaggi rispetto alla funzione renale e dati mancanti; score KFRE ed eGFR CKD-EPI calcolati dai dati già presenti.
- Assistente contestuale: domande sul paziente in corso, con risposta dai dati della cartella e dalla trascrizione.
- Referto HL7 CDA2 pronto per la firma; PDF/A-3 con CDA2 integrato per il repository documentale e il FSE 2.0.

IL MEDICO DECIDE

- Ogni proposta è una bozza non vincolante: le sezioni si modificano o si cancellano, e nessuna entra nel referto senza conferma esplicita.
- Gli avvisi sono schede informative: si accettano o si ignorano, non bloccano la prescrizione e non agiscono su altri sistemi.
- Ogni proposta conserva la frase da cui nasce: la trascrizione resta verificabile e, se serve, si rigenera.
- Il referto si emette solo con l'azione del medico. Senza microfono si lavora comunque: la compilazione manuale è sempre disponibile.

DATI E RISERVATEZZA

PRIVACY BY DESIGN

L'audio non si conserva

Lo stream vocale è elaborato in transito e diventa solo testo. Dopo la firma la trascrizione integrale si cancella: restano gli artefatti clinici validati dal medico.

Il paziente viaggia come codice

Anche dentro la rete aziendale, verso il motore passano solo codice interno, sesso, età, altezza e dati clinici. Mai nome, cognome, codice fiscale, recapiti o data di nascita.

Modelli dentro l'azienda

I modelli risiedono nell'infrastruttura dell'azienda ospedaliera: nessun dato clinico lascia la rete. Cifratura in transito e a riposo, accessi per ruolo, log di audit, chiavi mai nel browser.

SCHEDA TECNICA

AMBITO	**Nefrologia · dialisi**
LINGUA	**Italiano**
REFERTO	**HL7 CDA2 · PDF/A-3**
CONFERIMENTO	**FSE 2.0**

MODELLI	**Addestrati in nefrologia**
RESIDENZA	**Infrastruttura aziendale**
AUDIO CONSERVATO	**0 s**
DECISIONE CLINICA	**Medico**

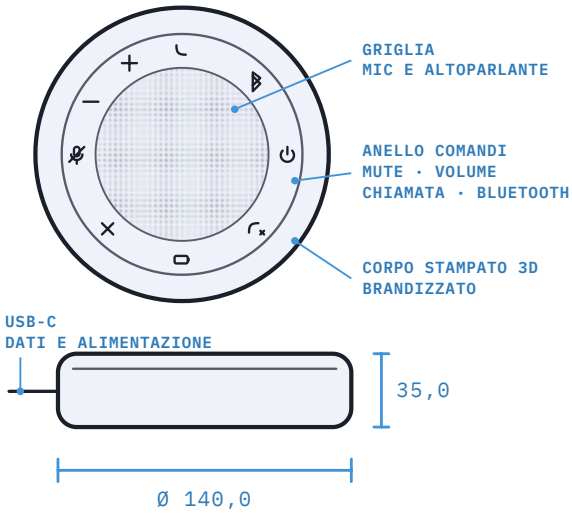
CONFIGURAZIONE PREVISTA PER L'ESERCIZIO

LA POSTAZIONE DI VISITA — HARDWARE LA TRACCIA

DUE DISPOSITIVI, UNA POSTAZIONE

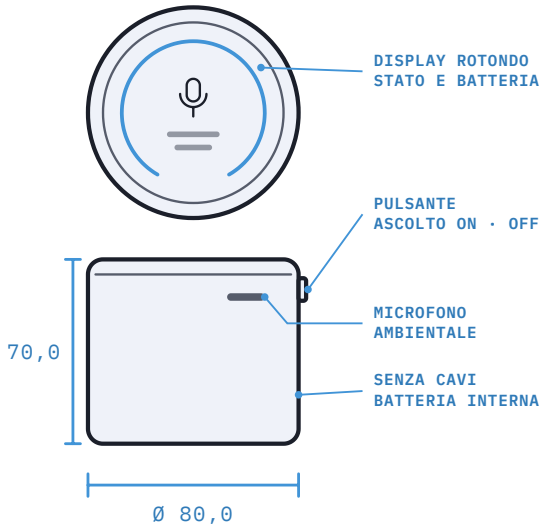
L'audio della visita entra da hardware progettato da La Traccia: un vivavoce da scrivania, cablato, e un'unità wireless con display per il bordo letto. Entrambi dialogano con Ambulatorio AI e si provano prima di ogni visita con il test di qualità dell'audio.

SCRIVANIA — CABLATO · USB-C



COLLEGAMENTO	**USB-C**
ALIMENTAZIONE	**Dal cavo**
MICROFONO	**Ambientale**
COMANDI	**Mute · volume · chiamata**

BORDO LETTO — WIRELESS · DISPLAY



COLLEGAMENTO	**Wireless**
ALIMENTAZIONE	**Batteria interna**
DISPLAY	**Rotondo**
COMANDI	**Pulsante di ascolto**

QUOTE DEI DISEGNI IN MM

IN COMUNE

Test audio prima della visita

Dal pannello impostazioni si prova il microfono: se il rapporto segnale-rumore non basta, il sistema lo dice prima di cominciare.

L'ascolto si vede

Il medico avvia e ferma l'ascolto; il display e il mute fisico mostrano al paziente quando il sistema sta trascrivendo.

Nessun audio a bordo

I dispositivi non registrano: lo stream va al motore dentro l'azienda e diventa testo. Spento il microfono, non resta nulla.

DOMINIO

2

DOMINI VALIDATI:
NEFROLOGIA E DIALISI

RESIDENZA

In azienda

CODIFICHE

ATC · ICD-10

SCORE

KFRE

MODELLI DI DOMINIO, DENTRO L'AZIENDA

I modelli linguistici e i dizionari di Ambulatorio AI sono addestrati sul lessico e sui percorsi della nefrologia e della dialisi, e risiedono nell'infrastruttura dell'azienda ospedaliera: nessun dato clinico lascia la rete. Un dominio clinico è fatto di quattro cose.

01 **Dizionario clinico**

Terminologia, abbreviazioni, farmaci ed esami del dominio, con le codifiche ATC, ICD-10, LOINC e SNOMED.

02 **Schema di visita**

Le sezioni del referto e i dati strutturati da riconoscere: in nefrologia anamnesi, esame obiettivo, esami, terapia, follow-up.

03 **Regole di avviso e score**

Allergie, interazioni, dosaggi in rapporto alla funzione d'organo, dati mancanti; gli score del dominio, come il KFRE.

04 **Validazione con i clinici**

Sessioni su pazienti sintetici con medici e infermieri della specialità, poi il pilot supervisionato su pazienti reali.

OLTRE LA NEFROLOGIA — LO STESSO METODO

LO STESSO METODO, ALTRI DOMINI

Modelli e dizionari sono stati messi alla prova sulla nefrologia e sulla dialisi, ma il metodo non dipende dalla specialità: dizionario, schema di visita, regole e validazione si costruiscono allo stesso modo per qualunque dominio clinico.

- TRAPIANTI D'ORGANO
- DIABETOLOGIA
- CARDIOLOGIA
- PNEUMOLOGIA

COSA SERVE ALLA STRUTTURA

- I referti tipo della specialità e le codifiche in uso: sono la base del dizionario e dello schema di visita.
- Due clinici per le sessioni su pazienti sintetici: validano avvisi, score e sezioni prima di ogni uso reale.
- L'istruttoria con DPO e Sistemi Informativi, la stessa già percorsa per la nefrologia.
- Nessun dato di pazienti reali fino al pilot, e nessun dato che esca dall'azienda nemmeno dopo.

IN CORSO

0

DATI DI PAZIENTI REALI NELLA FASE IN CORSO

AVVIO
1 set 2026

STATO
In corso

PAZIENTI
Sintetici

NATA A BASSANO CON L'AULSS 7 PEDEMONTANA

Ambulatorio AI nasce dalla collaborazione con la UOC di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, all'Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. L'idea, un microfono alla postazione di visita e un modello linguistico, è stata istruita con DPO, Sistemi Informativi e Direzione Sanitaria. La sperimentazione è partita il 1° settembre 2026 ed è tuttora in corso.

MAG 2026 — **La UOC propone il progetto**
Microfono, trascrizione e score di rischio: si apre l'istruttoria con il DPO.

GIU–LUG 2026 — **Istruttoria privacy e architettura**
Architettura e riscontro ai rilievi del DPO; per i pazienti sintetici il GDPR non si applica.

AGO 2026 — **Parere favorevole della Direzione Sanitaria**
Via libera a medici e infermieri dell'équipe per la fase in silico; protocollo operativo con la UOC.

1 SET 2026 — **Avvio delle sessioni**
Medici e infermieri simulano le visite su pazienti sintetici; i flussi sono abilitati.

OGGI — **Sperimentazione in corso**
Misure su tempi e qualità del referto, verso il pilot su pazienti reali con consenso.

COSA MISURA LA SPERIMENTAZIONE

Tempo
Tempo di scrittura del referto prima e dopo, durata complessiva della visita, tempo di chiusura amministrativa.

Qualità
Completezza delle sezioni, accuratezza della trascrizione e delle codifiche, pertinenza degli avvisi accettati dal medico.

Uso
Ergonomia della postazione e qualità dell'audio, personalizzazione dell'interfaccia, giudizio di medici e infermieri.

GEPADIAL

400+

INSTALLAZIONI
DI GEPADIAL

INTEGRAZIONI HL7
circa 200

REFERTO
CDA2

FIRMA
Digitale

UN MODULO ESTENSIVO DI GEPADIAL

GepaDial è la cartella clinica nefrologica di La Traccia, con oltre 400 installazioni: dialisi, ambulatorio e percorso trapianti sullo stesso paziente. Ambulatorio AI ne è un modulo estensivo, dentro il modulo Ambulatorio che copre la visita dal CUP alla firma.

01 **Agenda e accettazione**

Prenotazioni acquisite dal CUP, lista dei pazienti in visita oggi, stati da prenotato a refertato.

02 **Scheda visita**

Antropometria, ultimi esami, terapia domiciliare e storico referti in una vista; eGFR automatico; alert farmaco–allergia.

03 **Referto e FSE**

PDF/A-3 con CDA2 integrato, firma digitale, invio al repository; accreditato per il conferimento al FSE 2.0.

04 **Integrazioni**

Anagrafica, CUP e order entry, laboratorio, ADT, repository documentale; per i trapianti, il Centro Regionale.

IL PERCORSO DI ATTIVAZIONE

CON DPO E SISTEMI INFORMATIVI

01 **ISTRUTTORIA**

DPO, sistemi informativi, ingegneria clinica

02 **DATI SINTETICI**

Visite simulate da medici e infermieri

03 **PILOT**

Pazienti reali con consenso dedicato

04 **ESERCIZIO**

Avvio dopo la verifica delle misure

La sperimentazione è in corso dal 1° settembre 2026. Per una visita simulata dal vivo o per pianificare l'istruttoria:

- INFO@LATRACCIA.IT
- +39 0835 336836
- LATRACCIA.IT

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 · ISO/IEC 27001:2022 · UNI PdR 125 · UNI EN ISO 14001:2015 · UNI ISO 37001:2025 · PASS 24000:2022

LA TRACCIA

SISTEMI INFORMATIVI PER LA SANITÀ, INSTALLATI E SEGUITI NEL TEMPO

Cooperativa E.D.P. La Traccia progetta, installa e mantiene software per aziende sanitarie, enti e imprese. GepaDial è la sua cartella clinica nefrologica; Ambulatorio AI è il modulo che porta l'intelligenza artificiale dentro la visita.

SEDI

- MATERA · RECINTO II FIORENTINI, 10
- ALTAMURA · VIA G. D'ANNUNZIO, 6
- PARMA · VIA LA SPEZIA, 90
- POTENZA · VIA TORA, 23
- ROMA · VIA VITTORIO VENETO, 146

CONTATTI

- INFO@LATRACCIA.IT
- +39 0835 336836
- LATRACCIA.IT
- P.IVA 00317370773

GEPADIAL · AMBULATORIO AI · REV. 02 · OTTOBRE 2026

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015 · ISO 13485:2016 · ISO/IEC 27001:2022 · UNI PdR 125 · UNI EN ISO 14001:2015 · UNI ISO 37001:2025 · PASS 24000:2022